

Angioedema

1. Introducción y relevancia clínica

El **angioedema** es una **reacción edematosa localizada y súbita** de la piel, mucosas y tejidos submucosos, debida al **aumento de la permeabilidad vascular** mediada por **histamina o bradicinina**.

Compromete con frecuencia la **cara, labios, lengua, laringe y vías respiratorias superiores**, y puede evolucionar rápidamente hacia **obstrucción de vía aérea y muerte por asfixia** si no se maneja de forma inmediata.

Relevancia clínica

- Urgencia médica **potencialmente letal** por compromiso respiratorio.
 - Frecuentemente subdiagnosticado o confundido con urticaria simple.
 - Alta frecuencia en **servicios de urgencia y APS**, especialmente asociado a **fármacos (IECA, AINES, antibióticos)**.
 - El **MINSAL** lo considera parte del protocolo de **reacción alérgica severa / anafilaxia**.
 - El conocimiento de su **mecanismo fisiopatológico** (histamínico vs bradicinínico) guía el tratamiento correcto y evita errores graves.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo general

El angioedema se produce por **vasodilatación y extravasación de plasma** en tejidos subcutáneos o submucosos, secundarios a la liberación de mediadores vasoactivos.

2.2 Clasificación etiopatogénica

Tipo	Mediador principal	Características clínicas	Respuesta al tratamiento
Histamínico (alérgico o idiopático)	Histamina, leucotrienos, prostaglandinas	Asociado a urticaria, prurito, rápida respuesta a antihistamínicos/corticoides/adrenalina	Sí
Bradicinínico (hereditario o adquirido, o inducido por IECA)	Bradicinina	Sin prurito ni urticaria, progresión lenta, mala respuesta a antihistamínicos o adrenalina	No
Mixto o idiopático no alérgico	Mediadores combinados o desconocidos	Edema recurrente, a menudo sin causa evidente	Variable

2.3 Tipos específicos

1. Angioedema alérgico (histamínico)

- Mecanismo mediado por **IgE**, con degranulación mastocitaria.
- Causas: alimentos (mariscos, nueces), fármacos (penicilinas, AINES), picaduras.
- Curso rápido (minutos a horas) y buena respuesta a adrenalina + antihistamínicos + corticoides.

2. Angioedema por inhibidores de la ECA (bradicinínico adquirido)

- Mediado por **bradicinina** por inhibición de su degradación.
- No responde a adrenalina ni antihistamínicos.
- Puede ocurrir **tras meses o años de uso de IECA** (enalapril, lisinopril, captopril).

- Mayor riesgo en adultos mayores, raza afroamericana y mujeres.

3. Angioedema hereditario (AH)

- Autosómico dominante (déficit o disfunción del inhibidor de C1 esterasa).
- Crisis desencadenadas por trauma, estrés, procedimientos dentales, infecciones.
- Edema sin urticaria, de evolución lenta, puede afectar laringe o tubo digestivo (dolor abdominal tipo cólico).
- No responde a terapia convencional; requiere tratamiento específico con **concentrado de C1-INH o icatibant**.

2.4 Anatomía comprometida y riesgo vital

Zonas críticas:

- **Laringe y glotis** → riesgo de asfixia.
- **Lengua y piso de boca** → obstrucción posterior.
- **Uvula / epiglotis** → disfagia, disfonía, estridor.

El compromiso laríngeo es responsable de la mayoría de las muertes por angioedema.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

- **Edema súbito y no depresible** (a diferencia del edema por retención).
 - **Localización típica:** labios, párpados, lengua, glotis, manos, genitales.
 - **Sensación de picazón, ardor o tensión local.**
 - **Disfonía, disfagia, estridor o disnea** si compromiso de vía aérea.
 - En **AH**: dolor abdominal por edema intestinal.
-

3.2 Diferencias clínicas clave

Característica	Angioedema histamínico	Angioedema bradikinínico
Aparición	Rápida (minutos a horas)	Lenta (horas)
Duración	<24–48 h	2–5 días
Urticaria asociada	Frecuente	Ausente
Prurito	Frecuente	Ausente
Fármacos implicados	AINES, antibióticos	IECA
Respuesta a adrenalina / antihistamínicos	Buena	Nula
Antecedentes familiares	No	Sí (AH)

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Elementos diferenciales
Anafilaxia	Compromiso multisistémico: urticaria, hipotensión, broncoespasmo.
Urticaria aislada	Sin compromiso mucoso ni respiratorio.

Celulitis facial / absceso	Eritema, calor local, fiebre, evolución lenta.
Síndrome de Melkersson-Rosenthal	Edema facial crónico, parálisis facial recurrente.
Angioedema hereditario	Edemas recurrentes sin urticaria, antecedentes familiares.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

- Fundamentalmente clínico.
- Requiere **evaluación rápida del compromiso de vía aérea**.

4.2 Exámenes de apoyo (según contexto)

Examen	Utilidad
Hemograma, PCR	Descartar infección.
Complemento C4 y C1-INH (actividad y nivel)	Diagnóstico de AH.
Tryptasa sérica	Elevada en anafilaxia (mastocitos).
Test de alergia (IgE específica, prick test)	En sospecha de causa alérgica.
Función renal y hepática	Evaluar metabolismo de fármacos y bradicinina.

Diagnóstico confirmatorio de angioedema hereditario:

C4 bajo + C1-INH bajo o funcionalmente deficiente.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo depende del tipo y severidad del cuadro, priorizando vía aérea y oxigenación.

5.1 Manejo inicial (en todo nivel)

A – Airway (vía aérea):

- Evaluar signos de obstrucción: disfonía, estridor, sialorrea, retracción supraesternal.
- Preparar **intubación orotraqueal temprana** si compromiso laríngeo (operador experto).
- Si la intubación falla → **cricotiroidotomía o traqueostomía de urgencia**.

B – Breathing:

- Oxígeno 100% con mascarilla o cánula de alto flujo.
- Monitorización de saturación y signos vitales.

C – Circulation:

- Monitorizar PA, acceso venoso.
 - Manejo de hipotensión si asocia anafilaxia.
-

5.2 Tratamiento farmacológico

A. Angioedema histamínico (alérgico o idiopático)

1. Adrenalina IM (1:1000)

- 0,3–0,5 mg IM en muslo anterolateral.

- Repetir cada 5–15 min según respuesta.
- En niños: 0,01 mg/kg IM (máx 0,3 mg).

2. Antihistamínicos

- **H1:** clorfenamina 10 mg EV o difenhidramina 25–50 mg EV.
- **H2:** ranitidina 50 mg EV o famotidina 20 mg EV (opcional).

3. Corticoides

- Hidrocortisona 200–400 mg EV o dexametasona 8–12 mg EV.
- Previenen recurrencia y prolongación de síntomas.

4. Soporte

- Líquidos IV, oxígeno, monitoreo.
- Observación ≥ 6 h tras resolución (riesgo de rebote).

B. Angioedema bradikinínico (IECA o hereditario)

1. Suspender IECA inmediatamente.

2. No usar adrenalina, antihistamínicos ni corticoides como única terapia (ineficaces).

3. Tratamientos específicos:

- **Concentrado de inhibidor de C1 (C1-INH):** 20 U/kg EV (ideal < 2 h desde inicio).
- **Icatibant (antagonista de receptor B2 de bradicinina):** 30 mg SC.
- **Ecallantide (inhibidor de calicreína):** 30 mg SC (no disponible en Chile).

4. Si no se dispone, puede usarse:

- **Plasma fresco congelado (PFC)** 2 unidades EV (contiene C1-INH funcional).

5. Profilaxis a largo plazo (AH recurrente):

- Danazol o estanozolol (andrógenos atenuados).
- C1-INH profiláctico en procedimientos invasivos.

5.3 Criterios de hospitalización

- Cualquier **compromiso de vía aérea o lingual**.
- **Edema faríngeo, glótico o subglótico**.
- Angioedema **bradikinínico o hereditario**.
- Necesidad de intubación o vigilancia prolongada.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Asfixia	Por compromiso laríngeo progresivo. Causa principal de muerte.
Hipoxia cerebral	Por demora en manejo de vía aérea.
Rebote del edema	En formas alérgicas sin corticoides.
Muerte súbita	En pacientes que no reconocen el cuadro.
Secuelas	Escasas; posibles cicatrices posintubación o traqueostomía.

Pronóstico:

Excelente con reconocimiento precoz y manejo de vía aérea.

Peor en angioedema por IECA (recurrente, resistente) y hereditario no tratado.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas clínicas

1. **Edema sin prurito ni urticaria + uso de IECA = angioedema bradikinínico.**
2. **Adrenalina IM es la primera medida** en todo angioedema con sospecha de componente alérgico o compromiso respiratorio.
3. Si **no responde a adrenalina ni antihistamínicos**, sospechar **bradikinina** y administrar **C1-INH o icatibant**.
4. **Evaluar la vía aérea antes que cualquier examen.**
5. En pacientes con **angioedema hereditario**, el **estrés o procedimientos dentales** pueden desencadenar crisis → profilaxis con C1-INH.
6. En APS, si se sospecha angioedema bradikinínico, se debe **derivar urgente a hospital con terapia específica**.
7. **No usar IECA** en pacientes con historia previa de angioedema (contraindicación absoluta).

✗ Errores comunes

- Retrasar la **intubación** esperando respuesta farmacológica.
 - No suspender **IECA** ante episodio inicial.
 - Tratar angioedema bradikinínico como anafilaxia (sin efecto).
 - **Subestimar edema lingual o subglótico**, que puede progresar rápido.
 - Dar de alta pacientes con **recurrencias sin estudio de C1-INH**.
 - Falta de observación post crisis (puede reaparecer en 6–8 h).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **angioedema** es una urgencia potencialmente fatal por **compromiso de vía aérea superior**.
2. Se divide en **histamínico (alérgico)** y **bradikinínico (hereditario o inducido por IECA)**.
3. El **histamínico** responde a **adrenalina, antihistamínicos y corticoides**.
4. El **bradikinínico NO responde** a estos fármacos y requiere **C1-INH o icatibant**.
5. **Asegurar vía aérea** es la prioridad: intubación precoz o cricotiroidotomía si es necesario.
6. **Suspender IECA** de inmediato ante cualquier episodio de edema facial o lingual.
7. **Pronóstico excelente** si se maneja precozmente; la muerte ocurre por **asfixia no reconocida**.